ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

PROCESO DE REHABILITACIÓN EN PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN ETAPA INICIAL

Autores: Yuliana Londoño, Jacobo Franco, Juan David Guavita, Paula Soto, Camila Fernández, Donovan Caicedo, Miguel Gomez , Carlos Medina , Nicolas segura , Camila Cruz , Angely Tenorio, Santiago Cardenas , Yeraldin Ulloa , Juan Camilo Torres
Docente: ____Leslie Gamboa_ **Curso:** Tecnicas De Intervencion 1
Semestre: 6 semestre

Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es una patología neurodegenerativa y desmielinizante del SNC que altera la movilidad, marcha, equilibrio, destreza manual y cognición. Tradicionalmente se ha intervenido tras la aparición de discapacidad clínica evidente (EDSS). Sin embargo, existen déficits subclínicos desde fases iniciales (SCA, SRA, EMRR) que exigen un abordaje fisioterapéutico proactivo y estructurado desde el diagnóstico.

Planteamiento del problema

El malestar psicológico y la percepción individual de la enfermedad condicionan directamente la severidad de los síntomas informados en EM temprana. Las evaluaciones clínicas estándar no detectan limitaciones sutiles que afectan la calidad de vida. Esta revisión justifica implementar programas fisioterapéuticos proactivos que estimulen la neuroplasticidad, prevengan complicaciones por inactividad y promuevan la independencia a largo plazo.

Metodología

- Diseño del Estudio: Revisión de la literatura (estudios multicéntricos observacionales, transversales, series de casos CARE, revisiones sistemáticas PRISMA/PRISMA-ScR y guías clínicas).
- Bases de Datos: PubMed Central, ScienceDirect, SAGE Journals, Medigraphic, IJMSC, JIN, MEDLINE, Scopus, PEDro, Web of Science.
- Población: Adultos con diagnóstico reciente de EM (duración ≤18 meses a 5 años, EDSS ≤3.5).
- Evaluaciones:
  - Motoras: T25FW, 6MWT, NHPT, FAB, 5xSTS, FGA, HiMAT.
  - Cuestionarios / PROMs: SDMT, BICAMS, FSS, MFIS, MSWS-12, HADS, B-IPQ, SF-36.

Resultados

Discusión

- Detección Precoz: La ausencia de discapacidad clínica en la EDSS no equivale a preservación funcional. Evaluar con pruebas objetivas (6MWT, NHPT, SDMT) y cuestionarios reportados por el paciente (PROMs) permite identificar alteraciones sutiles.
- Modelo Proactivo (PAPT): Intervenciones de baja dosis con prescripción individualizada de ejercicio (≥150 min/semana) y seguimiento digital mejoran la movilidad y reducen la fatiga.
- Neuroplasticidad y Factores Psicosociales: La fisioterapia temprana favorece la neuroplasticidad. Abordar el malestar psicológico y la percepción de la enfermedad disminuye la carga sintomática.

Conclusión

1. La fisioterapia proactiva y personalizada desde las etapas iniciales es crucial para mitigar el avance del deterioro físico y cognitivo.
2. La combinación de pruebas funcionales objetivas y cuestionarios PROMs constituye la herramienta evaluativa más sensible.
3. Prescribir ejercicio adaptado y educación continua preserva la independencia y mejora la calidad de vida.

Bibliografías QR

1. Sainz de la Maza S, et al. Mult Scler Relat Disord. 2023;77:104947.
2. Cattaneo D, et al. Rev Neurol (Paris). 2022;178(9):912-921.
3. Thrue C, et al. Neurorehabil Neural Repair. 2025;39(2):112-124.
4. Saposnik FE, et al. J Affect Disord Rep. 2026;24:101023.
5. Learmonth YC. J Physiother. 2026;72(1):8-18.
6. Warutkar V, et al. Cureus. 2022;14(11):e31456.
7. Núñez Orozco L. Rev Mex Neuroci. 2023;24(2):18-35.
8. Hendricksen M, Boyer J. Int J MS Care. 2024;26(3):105-112.
9. Lorenzut S, et al. J Integr Neurosci. 2025;24(1):81.

ODS